

WEEKLY REPORT



小編：伊君

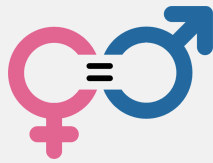
教學中心 & 實證醫學暨醫療政策中心週戰報

FRIENDLINESS



友善

EQUALITY



平等

ART



藝術

INSIGHT



洞察力

為何行動前的沉澱更重要

面對近幾年變動的大環境，以及這陣子推動的各種專案，我們總是被提醒要把**效益最大化**。然而，能做到的人，並非一開始就擁有最多資源或最快執行力的人，而是那些在**行動之前**，願意**深入思考**的人。

在醫院的環境裡，每一分鐘、每一個決定都攸關病人的安危。做任何事，不論是推動一項新政策、優化一個流程，甚至只是召開一場團隊會議，真正的起點不是「該怎麼做」，而是更本質的問自己：「為什麼要做？完成後會帶來什麼改變？誰會受到影響？我們為何如此在意這件事？」這些問題的背後，正是**設計思考**中的**第一步：同理 (EMPATHIZE)**，去理解人們真正的感受與需求。

當你對這些問題有了清晰的答案，效益自然會隨之聚焦，資源也才能被精準分配。這也正如設計思考強調的**第二步：定義問題 (DEFINE)**，它使我們聚焦在本質需求，而非表層解法。讓我們不僅解決表面的症狀，而是針對核心議題對症下藥。

在工作中，許多改革以「提升效率」為名展開，卻因未能觸及相關人員的真正需求而無疾而終。例如，推動同仁使用新系統時，若只關注「節省時間」這樣的技術效率，而忽略同仁真正在意的是「如何有更多時間陪伴自己的家人或如何準時上下班」，這樣的改革自然難以獲得認同。唯有**理解各方真正的需求**，才能釋放出最有價值的資源；**對準核心關切點**，才會**激發真正的行動**。

醫療體系中的每個環節，從行政、醫護到病人，都是相互依存的利害關係人。他們不是改變的阻力，而是潛在的助力。若能在計畫初期就換位思考：「他們最關心什麼？有什麼顧慮？我該如何表達，他們才會真正理解並支持？」這正是同理與洞察的具體實踐。即使是複雜的改革，也能因此找到突破點。

前置的沙盤推演，不是為了預測失敗或找藉口拖延，而是為了減少執行過程中的不必要摩擦。想過最壞的情況、準備好替代方案、時刻提醒自己「初衷是什麼」，你會發現自己不再被瑣碎的緊急事務淹沒，而是能在這個高壓環境中，依然保持清晰的方向感和從容的步調。

「畫中有話」 - 與奇美博物館合作「引導式藝術觀察課程」

從「看見」到「看懂」

在日常工作中，我們習慣快速的瀏覽問題，憑藉既有經驗迅速做出判斷，卻鮮少有機會真正靜下心來，細細觀察問題背後的結構與關聯。我們走進奇美博物館，透過觀賞畫作的方式，重新學習「如何看待事物」，並從中體會到一個重要道理-**效益的最大化**，源自於精準的觀察與多角度的理解。

PART 1 | 細節中的答案：來自精準觀察

在老師引導下，我們站在畫作前，刻意放慢步調，觀察每個細節：櫃子上的物件、人物的眼神、牆上的擺設。就像面對一個新的專案或制度變革，若只看表象，往往容易錯估重點。唯有先看清問題的全貌與脈絡，資源才能用在刀口上，決策也才能真正聚焦。



PART 2 | 觀察之外，更要重視感受

光是看到畫面還不夠，還需要理解畫中的情緒與關係。這正如推動一項變革時，不能只分析數據或設計流程，還要感受人的反應與需要。當學員分享他們的感受，有人看到緊張、有人感受喜悅，這種差異提醒我們：每一個利害關係人，都有不同的視角與關注焦點，真正的效益來自觸及他們真正的需求。

PART 3 | 推理與調整：策略靈活才能事半功倍

活動最後，我們從博物館研究的角度，解析畫作背後的歷史脈絡與象徵意涵，許多人的推測與實情產生了落差。這就像專案沙盤推演，不只是為了做對決策，而是為了在事前調整方向、降低阻力。

這場課程不只是藝術體驗，更是一次行動前的思考練習。**學習看見細節、理解他人、彈性調整**，是讓行動產生最大效益的三大關鍵。在人生的每一個路途中，願我們都能不只是看見，而是真正看懂，在開始做之前，想得更深、問得更準，走得更遠。

模擬教具縫合競賽



奇美醫學自2016年設立3D列印研究室，秉持「實現效益最大化」的精神，整合跨領域專家，開發擬真無毒軟性手術模型，提升住院醫師手術縫合技術。這些模型讓醫學生在無風險環境中反覆練習，強化技術、降低術中併發症，達到訓練與病人安全的雙重效益。同時結合標準病人訓練醫病溝通技巧，實踐全人照護，讓技術訓練更貼近臨床真實。

教學之路的起承轉合：AMEE醫學教育會議的奇幻旅程

4月底，教學領域特別邀請成大醫院教學中心林威宏執行長與高齡醫學部羅玉岱醫師，帶來他們參與歐洲醫學教育學會（AMEE）年會的第一手經驗，為本院醫學教育注入新思維。



林執行長從宏觀視角解析全球醫學教育趨勢，重點介紹了以學習者為中心、成果導向及能力導向的醫學教育理念，並說明了MINI-CEX及DOPS等評估工具。這些工具能提供即時回饋，同時也是促進學生能力發展上的重要角色。他也分享了成大在高齡醫學計畫中的課程模組設計及跨領域合作經驗，強調持續參與國內外教學會議對教師成長與教學品質的重要助益。

羅玉岱醫師則以「資深小白」的幽默視角，分享了她如何從地區醫院轉至醫學中心後，將PGY學生的居家醫療觀察轉化為具價值的質性研究。她成功投稿並站上AMEE國際舞台的歷程，展現了臨床經驗如何成為研究與國際對話的基石。她也從學生的心得中挖掘出對居家醫療技能、團隊合作以及對居家護理師的尊敬，反映出學生在實務中獲得的深刻體悟。



透過兩位醫師的精彩分享，我們深切體認到緊跟國際趨勢、強化臨床教師研究轉譯能力、優化教學評估與回饋機制的重要性。這將引領我們在提升奇美整體醫學教育品質及培育更符合未來醫療人才的道路上，邁出更堅實的步伐。

同仁專區1

破繭而出



VIBECODING通往數位魔法的鑰匙

分享者：教學中心曉琪

在現今的數位時代，許多平台和工具讓我們能夠輕鬆設計和創建網站，讓沒有程式設計背景的人可以快速上手，發揮創意。而這些創作的背後，都與VIBECODING的概念息息相關。

VIBECODING，是一種利用自然語言處理技術的創新方式，它將使用者的語言指令轉換成程式碼，簡化了網站或應用程式開發的過程。這種方式突破了傳統編程的技術門檻，讓沒有編程經驗的人也能夠創建自己想要的數位產品。VIBECODING所帶來的便捷性和高效性，無疑能夠讓使用者專注於創意的表達，而非難度高的編程撰寫。



類似的技術已經在一些知名平台中實現，例如 CANVA 的魔法編碼功能，輸入簡單的需求描述：「設計一個虛擬學習平台」，使用者只需要用自然語言描述想要的功能，即可將這些需求轉換成程式碼，並自動生成相應的網頁框架，讓使用者能夠快速見到成果。這種設計不僅提高了創作的效率，也讓更多人能夠參與到數位創作的過程中，實現他們的創意，使創意與實現之間的距離變得更近，並改變我們對程式設計的傳統認知。

同仁專區2

沒有辦不到，只有想不到

分享者：教學中心 英云

在現今的數位時代，許多平台和工具讓我們能夠輕鬆設計和創建網站，讓沒有程式設計背景的人可以快速上手，發揮創意。而這些創作的背後，都與 VIBECODING 的概念息息相關。

工具爆炸的時代

科技日新月異，離「不求人」的境界越來越近。靠著各式工具，八成的麻煩事差不多都能搞定。但在這個求新求變的時代，光有工具還不夠，自己也得持續升級，才能不被潮流甩在岸邊吃沙。

菜鳥上陣，過關斬將

最近挑戰用 SHAREPOINT 結合 POWER AUTOMATE，嘗試會議紀錄自動化簽核流程，直接請 GPT 把我當菜鳥，手把手帶著走。即使原理還是霧裡看花，靠著 GPT 生成的語法，還是跑起來了！後續不斷除錯、過關斬將，硬是把流程打通。過程雖然燒腦，但看到成果，成就感直接爆棚！

會議記錄簽核通知

會議名稱：測試中

[點我打開會議記錄資料夾](#)

請確認以上會議記錄，選擇簽核意見，並填寫回覆：

請輸入您的簽核意見

MM/dd/yyyy

☒ 核准

☐ 不同意

奇美跨領域團隊合作照護(IPP)記錄表單 1140426

用於記錄IPP團隊合作與照護情況

基本資訊

1. 姓名

輸入您的答案

2. 單位

輸入您的答案

3. 完成評量日期

請輸入日期 (yyyy/M/d)

下一步



實戰訓練，越練越順

4/26(六)早上參加院內教育訓練，由資訊室麗珍講解「送出 FORMS 表單，透過 POWER AUTOMATE 自動轉成 PDF 並存進 SHAREPOINT」。由於最近剛好實作類似流程，這次聽課終於不再有跟不上進度的壓力。課後也再度練習，將表單轉成線上流程，透過不斷熟悉與操作，花的時間越來越短，效率感直線上升。

邊學邊做，永無止境

工具的世界就像一班接一班的火車，剛下車，下一班又準備要發車。雖然有時候會想多待一會兒喘口氣，但時間一到，還是得提起行李再上車。一路上邊學邊做，邊修邊補，總算從迷路的小旅客，慢慢變成跟得上節奏的乘客。下一站會是哪裡？不知道，但車子總會開，目的地總會到，反正就繼續向前進吧！

美國鄉村歌手 - 吉米·狄恩

I CAN'T CHANGE THE DIRECTION
OF THE WIND, BUT I CAN ADJUST
MY SAILS TO ALWAYS REACH MY
DESTINATION.

我不能改變風向，但
我能調整風帆，讓我
到達目的地。